

消化性溃疡诊疗规范

一、概述

1. 定义

- 消化性溃疡(peptic ulcer,PU)指胃肠道黏膜被胃酸/胃蛋白酶自身消化形成的溃疡,深度超过黏膜肌层
- 主要包括胃溃疡(gastric ulcer,GU)和十二指肠溃疡(duodenal ulcer,DU)
- 十二指肠溃疡多于胃溃疡,比例约为3:1
- 好发部位:DU多位于十二指肠球部前壁;GU多位于胃角和胃窦小弯侧

2. 流行病学

- 人群患病率约5%-10%,一生中患病风险约10%
- 男性多于女性,DU好发于青壮年,GU好发于中老年
- 秋冬和冬春交替季节高发

二、病因与发病机制

1. 幽门螺杆菌(Hp)感染

- Hp感染是消化性溃疡最主要的病因,DU患者Hp感染率约90%-100%,GU约80%-90%
- Hp通过尿素酶、空泡毒素(VacA)、细胞毒素相关蛋白(CagA)等损伤黏膜
- Hp感染引起胃酸分泌异常:DU患者胃酸分泌增多,GU患者黏膜防御功能下降为主
- 根除Hp可显著降低溃疡复发率(由50%-70%降至5%以下)

2. NSAIDs及阿司匹林

- 非甾体抗炎药(NSAIDs)是第二大病因,通过抑制环氧合酶-1(COX-1)减少前列腺素合成,削弱黏膜屏障
- 长期服用NSAIDs者溃疡发生率约15%-30%
- NSAIDs相关溃疡特点:多为胃溃疡、常无症状、首发表现可为出血或穿孔
- 危险因素:高龄(>65岁)、既往溃疡病史、大剂量或联用多种NSAIDs、联合糖皮质激素或抗凝药、Hp感染

3. 应激性溃疡

- 严重创伤、烧伤、大手术、休克、颅脑病变(Cushing溃疡)、严重感染等应激状态可致急性黏膜病变
- 机制:黏膜缺血缺氧、黏液-碳酸氢盐屏障破坏、胃酸反弥散
- ICU患者高危因素:机械通气>48小时、凝血功能障碍

4. 其他病因

- 胃酸分泌异常:胃泌素瘤(Zollinger-Ellison综合征)致难治性、多发性溃疡

- 吸烟:延缓溃疡愈合、增加复发
- 遗传易感性:O型血者DU风险增高
- 其他药物:糖皮质激素、氯吡格雷、双膦酸盐、化疗药物
- 胃十二指肠运动异常、胆汁反流

三、临床表现

1. 典型症状

- 慢性过程:病史可达数年甚至十余年
- 周期性发作:发作期与缓解期交替,常与季节相关
- 节律性上腹痛:
- DU:空腹痛、夜间痛,进食或服抗酸剂缓解(疼痛-进食-缓解)
- GU:餐后0.5-1小时疼痛,至下次进餐前缓解(进食-疼痛-缓解)
- 疼痛性质:钝痛、灼痛、胀痛或饥饿样不适

2. 不典型表现

- 部分患者仅表现为上腹不适、腹胀、反酸、嗝气、恶心等消化不良症状
- 老年人、NSAIDs相关溃疡可无疼痛,以出血或穿孔为首发表现
- 球后溃疡:夜间痛和背部放射痛明显,易出血,内科治疗效果差
- 幽门管溃疡:餐后即痛,呕吐多见,易并发梗阻

3. 体征

- 发作期上腹部局限性轻压痛
- DU压痛点偏右,GU压痛点偏左或剑突下

四、并发症

1. 出血

- 最常见并发症,发生率约15%-25%
- 表现:呕血、黑便(BP下降、头晕、心悸),每日出血量>50ml出现黑便,胃内积血>250ml引起呕血
- 出血量>1000ml或短期内>循环血量20%可出现失血性休克
- 约10%-15%患者以出血为首发症状

2. 穿孔

- 发生率约1%-5%,DU穿孔多于GU
- 急性穿孔:突发剧烈上腹痛,迅速波及全腹,板状腹、压痛反跳痛,肝浊音界缩小或消失,立位腹平片膈下游离气体(阳性率约80%)
- 慢性穿孔(穿透性溃疡):疼痛节律改变、顽固持续,常穿透至胰腺(背部放射痛)

3. 幽门梗阻

- 发生率约2%-4%,多由DU或幽门管溃疡引起
- 分为功能性(水肿痉挛,可逆)和器质性(瘢痕狭窄,需手术)
- 表现:餐后上腹饱胀、呕吐隔夜宿食、不含胆汁,可见胃型及蠕动波,振水音阳性
- 可致低氯低钾性碱中毒、脱水、营养不良

4. 癌变

- 胃溃疡癌变率约1%-3%,十二指肠溃疡几乎不癌变
- 警惕信号:年龄>45岁、疼痛节律消失、消瘦、贫血、大便潜血持续阳性、内科治疗8周不愈
- 胃溃疡患者应常规多点活检并随访胃镜至溃疡愈合

五、辅助检查

1. 胃镜检查

- 首选确诊方法,可直接观察溃疡部位、大小、形态,并取活检鉴别良恶性
- 溃疡分期(崎田分期):活动期(A1、A2)、愈合期(H1、H2)、瘢痕期(S1、S2)
- A1期:溃疡底覆厚白苔,周围黏膜充血水肿明显
- A2期:白苔清洁,周围水肿减轻,出现再生上皮红晕
- 恶性溃疡内镜特征:溃疡不规则、底凹凸不平、苔污秽、边缘结节状隆起、周围黏膜中断僵硬

2. X线钡餐

- 直接征象:龛影;间接征象:局部压痛、胃大弯侧痉挛性切迹、十二指肠球部激惹和变形
- 适用于不能耐受胃镜者,准确率低于胃镜,不能取活检

3. Hp检测

- 侵入性:快速尿素酶试验(胃镜下)、组织学检查、Hp培养
- 非侵入性:13C或14C尿素呼气试验(根除后复查首选)、粪便Hp抗原检测、血清抗体(不能区分现症与既往感染)
- 检测前需停用PPI至少2周、抗生素及铋剂至少4周,避免假阴性

4. 实验室检查

- 血常规:贫血提示慢性失血
- 大便潜血:阳性提示活动性出血
- 怀疑胃泌素瘤:空腹血清胃泌素(>1000pg/ml有诊断意义)、胃酸分析(BAO>15mmol/h)

六、诊断与鉴别诊断

1. 诊断要点

- 慢性、周期性、节律性上腹痛的典型病史
- 胃镜发现溃疡病灶为确诊依据
- X线钡餐发现龛影亦可确诊

2. 鉴别诊断

- 慢性胃炎、功能性消化不良:症状相似,胃镜可鉴别
- 胃癌:必须鉴别,胃溃疡需多点活检并随访愈合情况
- 胃泌素瘤:难治性、多发性、球后溃疡,伴腹泻,胃泌素显著升高
- 胆囊炎胆石症:右上腹痛,进食油腻诱发,B超可鉴别
- 冠心病心绞痛:中老年上腹痛需心电图排除心肌梗死

七、内科治疗

1. 治疗目标

- 消除病因、缓解症状、促进愈合、预防复发和并发症

2. 一般治疗

- 规律饮食,避免过饱、辛辣刺激、浓茶咖啡
- 戒烟限酒
- 停用或减量NSAIDs,必要时换用COX-2选择性抑制剂
- 避免过度劳累和精神紧张

3. 抑酸治疗(PPI为首选)

- 质子泵抑制剂(PPI)标准剂量:
- 奥美拉唑20mg,每日1-2次,餐前30分钟口服
- 兰索拉唑30mg,每日1次
- 泮托拉唑40mg,每日1次
- 雷贝拉唑10-20mg,每日1次
- 艾司奥美拉唑(埃索美拉唑)20-40mg,每日1次
- 艾普拉唑5-10mg,每日1次
- 疗程:十二指肠溃疡4-6周;胃溃疡6-8周
- 难治性溃疡:可加倍PPI剂量或延长疗程至8-12周
- H₂受体拮抗剂(替代方案):法莫替丁20mg每日2次,雷尼替丁150mg每日2次,疗程GU8周、DU6周,疗效弱于PPI

4. 根除Hp治疗

- Hp阳性溃疡患者必须根除治疗
- 首选铋剂四联方案:PPI标准剂量每日2次+枸橼酸铋钾220mg每日2次+两种抗生素,疗程14天

- 常用抗生素组合:阿莫西林1000mg每日2次+克拉霉素500mg每日2次;青霉素过敏者换用左氧氟沙星500mg每日1次或四环素、呋喃唑酮等
- 根除后复查:停药4周以上行¹³C/¹⁴C尿素呼气试验
- 详见《Hp根除方案》

5. 黏膜保护剂

- 枸橼酸铋钾:120mg每日4次或220mg每日2次,疗程不超过8周,长期使用警惕铋蓄积
- 硫糖铝:1g每日3-4次,餐前1小时及睡前服用
- 铝碳酸镁:0.5-1g每日3次,餐后1-2小时嚼服,兼有抗酸和吸附胆汁作用
- 瑞巴派特、替普瑞酮、米索前列醇(200 μg每日4次,预防NSAIDs溃疡,孕妇禁用)

6. NSAIDs相关溃疡的防治

- 能停用NSAIDs者:停药+PPI标准剂量治疗, GU 6-8周、DU 4-6周
- 不能停用NSAIDs者:PPI治疗基础上,溃疡愈合后继续PPI维持预防
- 高危人群预防:PPI标准剂量每日1次,或米索前列醇
- 优先选择COX-2选择性抑制剂(如塞来昔布),但注意心血管风险
- 合并Hp感染者应在开始长期NSAIDs治疗前根除Hp

7. 维持治疗

- 适应证:反复复发、Hp阴性溃疡、不能停用NSAIDs、有并发症史、高龄
- 方案:PPI半量或标准剂量每日1次,或H₂RA睡前顿服,疗程视病情3-12个月或更长

八、出血性溃疡的处理流程

1. 病情评估与复苏

- 立即评估生命体征,建立两条静脉通道
- 查血常规、血型、交叉配血、凝血功能、肝肾功能
- 容量复苏:晶体液快速输注;输血指征:血红蛋白<70g/L(或<90g/L伴活动性出血/心血管疾病)
- 休克指数(脉率/收缩压)>1提示失血量>20%-30%

2. 药物止血

- 大剂量PPI静脉给药:艾司奥美拉唑或泮托拉唑80mg静脉推注后,以8mg/h持续静脉泵入72小时
- 生长抑素及其类似物:奥曲肽首剂0.1mg静推,后25-50 μg/h维持
- 内镜止血成功后继续PPI静脉用药72小时,后改口服

3. 内镜治疗

- 血流动力学稳定后24小时内行急诊胃镜(最好在出血后12-24小时)
- 内镜下止血方法:注射肾上腺素(1:10000)、热凝(热探头、APC)、金属夹、联合治疗
- Forrest分级指导处理:

- Ia级(喷射性出血)、Ib级(活动性渗血):内镜下止血,再出血率高,需积极处理
- IIa级(裸露血管):内镜下止血
- IIb级(血凝块附着):冲洗后评估,可考虑内镜处理,强化PPI治疗
- IIc级(黑色基底)、III级(基底洁净):无需内镜止血,常规PPI治疗
- 再出血风险评估:Rockall评分、Blatchford评分

4. 介入与手术

- 内镜止血失败或再出血:血管造影栓塞治疗
- 手术指征:内镜及介入治疗失败、大出血休克难以纠正、穿孔、瘢痕性幽门梗阻、疑癌变
- 手术方式:穿孔修补术、胃大部切除术、迷走神经切断术等

5. 穿孔与梗阻的处理

- 急性穿孔:禁食、胃肠减压、补液、抗感染,多数需急诊手术;小的穿孔且腹膜炎局限者可保守观察
- 幽门梗阻:禁食、胃肠减压、纠正水电解质紊乱,PPI治疗;功能性梗阻多可缓解,瘢痕性梗阻需内镜下扩张或手术

九、随访与预防

1. 随访

- GU患者治疗后6-8周复查胃镜确认愈合并再次活检排除恶性
- DU症状缓解后可不复查,但需确认Hp根除
- 有出血史者评估再出血风险

2. 预防复发

- 根除Hp是预防复发最关键措施
- 避免不必要的NSAIDs使用,必须使用时应联合PPI
- 戒烟、规律饮食、避免精神应激
- 高危患者长程维持抑酸治疗

> 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。